

Documento elaborado por:	Documento revisado por:	Documento aprobado por:
Enfermera Katherine Muñoz	TM Diego Cabrera Leiva I. Comercial M. Ignacia Tapia B.	QF Marcelo Tapia Carrère
FECHA: 27/05/2019	FECHA: 29/05/2019	FECHA: 31/05/2019

1. TOMA DE MUESTRAS DE ORINA AISLADA DE SEGUNDO CHORRO, O PRIMER CHORRO SEGÚN CORRESPONDA

I. Objetivo:

Establecer un nuevo procedimiento para la obtención de muestra de orina, en calidad y cantidad óptima para su análisis de laboratorio, utilizando un sistema al vacío.

II. Alcance:

- Personal de enfermería que cumpla funciones en las salas de toma de muestras del laboratorio.
- Personal de secretaría.

III. Responsable de la ejecución:

Enfermera, Matrona o Técnico en enfermería.

IV. Definiciones:

- **Dispositivo de transferencia de orina:** el dispositivo de transferencia de orina permite una transferencia limpia de la muestra de orina, directamente a los tubos para orina.
- **Frasco de orina al vacío:** frascos de 100 o 120 ml diseñados para utilizar con tubos de vacío. Permiten una transferencia limpia de la prueba de orina contenida en el frasco directamente al tubo de vacío. Estos frascos están fabricados en polipropileno transparente. Tapón hermético en polietileno amarillo con anillo interno de obturación. Incorpora una cánula con una boquilla de aspiración y una aguja, protegida por un capuchón de caucho. El tapón incluye una etiqueta de aviso para evitar el riesgo de pinchazo al usuario.
- **Tubo de orina al vacío:** los tubos para orina se utilizan como recipientes colectores o de transporte. Los tubos son estériles, a prueba de fugas y están hechos de plástico transparente e irrompible desechable. Los tubos para orina de base cónica se utilizan para el examen microscópico de la sedimentación urinaria.

V. Metodología:

1) Materiales:

- ➔ Tórulas limpias.
- ➔ Frascos de orina estéril sistema al vacío.
- ➔ Tubo de orina estéril sistema al vacío.
- ➔ Jarro con agua jabonosa y tibia.
- ➔ 2 Etiquetas para rotular: una para el frasco de orina al vacío y otra para el tubo de orina al vacío.
- ➔ Bolsa contenedora de frasco estéril.

2) Procedimiento:

1. Llamar al paciente según “Protocolo de atención”.
2. Verificar los exámenes solicitados en la orden médica.
3. Imprimir los códigos de barra para rotular muestra(s) de examen(es) solicitado(s).
4. Reunir el material.
5. Preparar al paciente, explicando el procedimiento de aseo externo (según instructivo – paciente hombre o mujer-).

NOTA: Advierta al paciente que no quite el adhesivo de seguridad que hay en la tapa para que no pueda pincharse con la aguja de la cánula, situada en el dispositivo de transferencia integrado.

6. Abrir el recipiente de recogida de orina.
7. Dejar tapa (hacia arriba) y recipiente sobre una superficie limpia.
8. No tocar las partes internas del recipiente con las manos.
9. **a) Para orina de segundo chorro:** pedir al paciente que, de la primera orina de la mañana, elimine en WC el primer chorro, luego retenga, para finalmente depositar el segundo chorro de orina directamente en el frasco estéril.

b) Para orina de primer chorro: pedir al paciente que deposite el primer chorro, de la primera orina de la mañana, directamente en el frasco.

10. Llenar con orina unos 3/4 del recipiente.

NOTA: En un frasco abierto, el nivel mínimo de llenado debe ser de 20 ml y, el nivel máximo, de 90 ml.

11. Cerrar fuertemente el frasco, roscándolo correctamente en sentido horario.

12. Homogeneizar muestra gentilmente.

13. Rotular con el nombre y dos apellidos del paciente.

14. Verificar si el paciente está con tratamiento de antibiótico.

Funciones exclusivas del profesional de toma de muestra:

15. Retirar la etiqueta protectora de la tapa, hasta que se descubra el orificio para la inserción del tubo.

16. Insertar el tubo amarillo en el recipiente con el tapón hacia abajo, hasta que la aguja perfora el tapón del tubo y haga tope. Mantener una pequeña presión sobre el tubo y esperar a que el tubo se llene.

17. Remover el tubo y pegar nuevamente la etiqueta protectora de la tapa del frasco.

NOTA: El volumen mínimo de llenado en un frasco cerrado, debe ser de 20 ml para llenar un solo tubo y, al tomar muestras en más de un tubo, el volumen mínimo de llenado del frasco debe ser de 40 ml. El volumen máximo de llenado debe ser de 100 ml.

18. Mover el tubo de orina 2-3 veces para homogeneizar la muestra.

19. Etiquetar el frasco y el tubo correspondiente y refrigerar ambos.

20. Registrar en el voucher de atención la hora y el nombre de quién recepciona la muestra.

3) Consideraciones:

- ✓ Es ideal tomar la muestra a primera hora de la mañana, cuando el paciente despierta, ya que **esa orina es más concentrada y permite detectar mejor las alteraciones.**
- ✓ La eliminación del primer chorro, permite arrastrar los gérmenes que se ubican en la porción distal de la uretra, los que podrían contaminar la muestra.

✓ **PARA MUESTRAS TOMADAS EN DOMICILIO:**

Aquellas orinas recolectadas en domicilio, deben ser entregadas en el laboratorio antes de 2 horas transcurridas desde que se realizó la muestra, en especial los **urocultivos** (orina fresca). **Estas deben ser refrigeradas en todo momento.**

✓ **PARA MUESTRAS PENDIENTES:**

En el caso de que el paciente registre su muestra pendiente, la etiqueta correspondiente al tubo de orina al vacío **debe ir pegada en la copia del voucher de atención de propiedad del laboratorio.**

✓ **PARA MUESTRAS POSTERIORES A LA ATENCIÓN O PENDIENTES DE DÍAS ANTERIORES:**

Para muestras tomadas en el baño -de la sucursal- posterior a la atención, o pendientes de días anteriores, **NO realizar los puntos 15, 16, 17 ni 18**, es decir, **NO transferir la orina desde el frasco al tubo.** Por lo tanto, se envía al laboratorio el frasco de orina al vacío rotulado más el tubo de orina correspondiente también rotulado, pero **VACÍO** (sin orina).

4) Instrucciones para recolectar orina con kit al vacío:

Abra el kit y separe el recipiente de orina del tubo. **Nunca quite el tapón del tubo de orina, perdería el vacío y la esterilidad.**



1.- Abrir el recipiente de recogida de orina.	2.- Dejar la tapa y el recipiente sobre una superficie limpia.	3.- No tocar las partes internas del recipiente con las manos.	4.- Llenar unos 3/4 del recipiente con orina.	5.- Cerrar fuertemente el frasco roscándolo correctamente.
---	--	---	---	--



6.- Homogeneizar la muestra gentilmente.	7.- Retirar la etiqueta protectora de la tapa hasta que se descubra el orificio para la inserción del tubo.	8.- Insertar el tubo amarillo en el recipiente con el tapón hacia abajo hasta que la aguja perfora el tapón del tubo y haga tope. Mantener una pequeña presión sobre el tubo y esperar a que el tubo se llene.	9.- Remover el tubo y pegar la etiqueta protectora.	10.- Mover el tubo de orina 2-3 veces para homogeneizar la muestra.
--	---	--	---	---